

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSKESMAS MIRIT
DENGAN
RSU PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

NOMOR: 400.7.2 / 011 / PKS/VIII/2026

NOMOR: 072 / Sp / PKU.5 / VIII / 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 dr. TUTUT TYAS WIJI : Kepala Puskesmas Mirit,
HASTUTI berkedudukan di Kebumen, beralamat di Jl. Daendels Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen Nomor Telepon (0287) 6651014 Kode Pos 54395, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Puskesmas Mirit selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 dr. H. HASAN BAYUNI : Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Sruweng berkedudukan di Kecamatan Sruweng, beralamat di Jalan Raya Sruweng Nomor 5 Sruweng, Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSU PKU Muhammadiyah Sruweng yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Sruweng adalah rumah sakit tipe kelas C yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang telah terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Kebumen beralamat di Jalan Raya Sruweng Nomor 5 Sruweng, Kebumen;
2. Puskesmas Mirit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif yang telah terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkedudukan di Kebumen beralamat di Jl. Daendels Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;

3. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas kesehatan.
5. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal;
6. Pelayanan Rujukan Pasien adalah proses pelimpahan tanggung jawab pelayanan medis secara timbal balik dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama ke faskes yang lebih mampu (spesialis/lanjutan).

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan kerja sama pelayanan rujukan pasien yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan Kesehatan rujukan bagi Pasien Puskesmas Mirit
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK guna memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

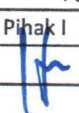
- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelayanan rujukan kesehatan terhadap pasien PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan oleh PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Intensif, Pelayanan Gawat Darurat, Rawat Inap, Rujukan Tindakan Spesialistik dan/atau Sub-Spesialistik, dan Pelayanan Penunjang yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Program rujuk balik dan penanganan permasalahan kesehatan berpotensi KLB
- (4) Koordinasi Data : Pertukaran informasi medis dan pelaporan kesehatan secara berkala
- (5) Promosi kesehatan berkelanjutan (edukasi kesehatan atau program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan)

BAB III PROSEDUR RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA akan merujuk Pasien apabila:
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik;
 - b. Tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, penunjang dan fasilitas kesehatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk balik Pasien kepada PIHAK PERTAMA apabila:
 - a. Permasalahan kesehatan Pasien dapat ditangani oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK PERTAMA akan lebih baik dalam menangani Pasien tersebut;
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK PERTAMA sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
- (3) PIHAK PERTAMA harus mendapatkan persetujuan dilakukannya rujukan dari Pasien dan/atau keluarga Pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

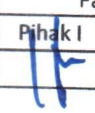
Paraf	
Pihak I	Pihak II
	Dn

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA sebelum merujuk terlebih dulu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. melakukan komunikasi awal dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima pasien dalam keadaan pasien gawat darurat;
 - c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas pasien;
 2. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 3. diagnosis kerja;
 4. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan/yang diminta;
 5. alasan dan tujuan rujukan;
 6. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan; dan
 7. status pembiayaan pasien
 - d. menginformasikan pada pasien rujukan agar membawa dokumen kependudukan dan dokumen kesehatan serta dokumen lain yang diperlukan atau dilengkapi kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (2) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat oleh tenaga medis (dokter).
- (3) Komunikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PIHAK PERTAMA menghubungi PIHAK KEDUA untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan sarana prasarana, kompetensi, dan tenaga kesehatan. Komunikasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pasien dirujuk.
- (4) Pendaftaran pasien dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan berdasar pada surat rujukan yang dibawa oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari Pasien dan bertanggungjawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 5

- (1) Pada saat mengirim rujukan, pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulance PIHAK PERTAMA dan didampingi oleh tenaga medis/paramedis yang berkompeten.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dalam hal tidak tersedia ambulance pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, maka rujukan dapat dilakukan dengan alat transportasi lain yang layak.
- (3) Petugas medis/paramedis yang mendampingi rujukan pasien harus menunjukkan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan.
- (4) Penempatan pasien yang memerlukan pelayanan rujukan kesehatan disesuaikan dengan kelas perawatan yang diminta oleh pihak keluarga yang bertanggungjawab.
- (5) Rujukan dianggap telah terjadi apabila Pasien telah diterima oleh PIHAK KEDUA setelah melalui rangkaian prosedur sebagaimana diatur dalam BAB III Perjanjian ini.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pasien berupa pemeriksaan penunjang yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, sedangkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap menjadi tanggung jawab Pasien.
- (2) Tarif pelayanan ditentukan berdasarkan daftar tarif pelayanan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan bagi pasien rujukan PIHAK PERTAMA yang dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA secara paripurna, bermutu dan profesional;
 - b. memperoleh informasi, penjelasan dan data yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan selama proses rujukan berlangsung;
 - c. memberikan saran dan masukan sehubungan dengan kerjasama yang dilakukan dengan PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima umpan balik hasil rujukan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan skrining dan penegakan diagnosis awal sesuai kompetensi Faskes I
 - b. melakukan prosedur rujukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam BAB III;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Paraf	
Pihak I	Pihak II
a	

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2026 sampai dengan 31 Juli 2029 dan akan dievaluasi setiap semester atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu PIHAK hendak memperpanjang Perjanjian ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini harus mengajukan

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 8

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menerima rujukan pasien dari PIHAK PERTAMA yang dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan secara lengkap, bermutu dan profesional sesuai standar prosedur operasional ;
 - c. menyediakan layanan informasi melalui telepon untuk pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. memberikan umpan balik terhadap kasus yang dirujuk secara tertulis dan dikirim kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - f. menanggapi dan menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. mendapatkan informasi dan data mengenai keadaan pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA;
 - b. menolak pasien yang tidak dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA karena keterbatasan fasilitas, peralatan, tenaga medis, atau alasan medis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mengirimkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi apabila diperlukan;
 - d. menagih biaya pelayanan sesuai tarif yang berlaku;
 - e. memberikan saran dan masukan dengan kerjasama yang dilakukan dengan PIHAK PERTAMA; dan
 - f. mengakhiri kerja sama apabila PIHAK PERTAMA melakukan wanprestasi.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - c. menaati tata tertib dan ketentuan pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - d. menjamin keabsahan administrasi rujukan pasien
 - e. menanggapi dan menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - f. tidak melakukan intervensi terhadap keputusan klinis tenaga medis PIHAK KEDUA.

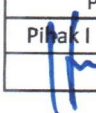
permohonan perpanjangan kepada PIHAK lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

BAB VII
KERAHASIAAN MEDIS
Pasal 9

PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas pasien dan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktu; dan/atau
 - b. Salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini dan tetap tidak mematuhi atau tidak berusaha untuk memperbaiki setelah menerima surat teguran /peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) dari hari kalender.
- (2) Apabila salah satu pihak menghendaki pengakhiran perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian habis, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian diakhiri.
- (3) Pengakhiran Perjanjian tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing PIHAK yang belum terlaksana sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (4) Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (5) Dalam hal berakhirnya perjanjian maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara salah satu pihak, harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan di luar kemampuan PARA PIHAK, terkecuali kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender saat terjadi peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak akan menuntut PIHAK lain atas tertundanya pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure*.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 13

Perjanjian ini tidak berakhir dengan bergantinya pimpinan salah satu pihak, tetapi akan diteruskan oleh pengganti dari salah satu pihak yang terdapat pergantian pimpinan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Segala perubahan, pencabutan dan pembatalan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat, kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

BAB XIII
ALAMAT KORESPONDENSI
Pasal 15

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan, apabila terdapat tanda penerimaan yang sah dari PIHAK yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama Instansi : Puskesmas Mirit
Alamat : Jl. Daendels Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit,
Kabupaten Kebumen

PIC Kerjasama
Nama : Yuni Listyorini, SST
Jabatan : Penanggung jawab Klaster I (Manajemen)
Nomor Telepon : 082241666388

(2) PIHAK KEDUA

Nama Instansi : RSUD PKU Muhammadiyah Sruweng
Alamat : Jl Raya Sruweng No 5 Sruweng Kebumen

PIC Kerjasama
Nama : Tri Dina Lestari, S.Kep.Ns
Jabatan : Manager Bindatra
Nomor Telepon : 081327667333

BAB XIV
ADDENDUM
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

BAB XV
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu buah untuk PIHAK PERTAMA dan satu buah lagi untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PUSKESMAS MIRIT



dr. Tutut Tyas Wiji Hastuti
Kepala Puskesmas

PIHAK KEDUA
RSU PKU MUHAMMADIYAH
SRUWENG



dr. H. Hasan Bayuni
Direktur Utama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	<i>Du</i>